Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico San Callisto
Dipartimento di Scienze di Laboratorio e Infettivologiche
UOC Microbiologia e Virologia - Laboratorio di Retrovirologia
Direttore: Prof.ssa Antonella Ciriello

Via Casilina Vecchia 211
00182 Roma
Tel. 06 49971820 - Fax 06 49971829
retrovirologia@aou-sancallisto.example.it

REFERTO DI LABORATORIO

Monitoraggio immuno-virologico - follow-up semestrale

DATI DEL PAZIENTE

Cognome:	**DE ANGELIS**
Nome:	**RICCARDO**
Nato il:	**19/06/1982**
Sesso:	**M**
Residenza:	**Via dei Castani 88/B 00172 Roma**
Cellulare:	**+39 339 418 2075**
Tessera sanitaria:	**80380090662771579783**
Esenzione:	**020**

N. accettazione:	26RV013388
Prenotazione CUP:	CUP-26-7718204
Richiedente:	Dott. Alessio Marchionni
Provenienza:	Ambulatorio Malattie Infettive - Day Service HIV
Prelievo:	28/09/2026 ore 08:05
Prelevatore:	inf. Gianluca Proietti
Referto:	05/10/2026

Provetta: RV26-13388-A

Codice fiscale D N G R C R 8 2 H 1 9 H 5 0 1 Y

Notizie cliniche (dal modulo di richiesta)

Pz. di 44 aa. con infezione da HIV-1 nota dal marzo 2014, fattore di rischio MSM, in terapia antiretrovirale con bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide 50/200/25 mg 1 cp/die. In anamnesi uso di metanfetamine in contesto di chemsex, attualmente in carico al SerD Roma Est (referente Dott.ssa Ilaria Fabbri). In anamnesi anche sindrome di Gilbert. Profilassi per Pneumocystis jirovecii sospesa nel 2016. All'ultima visita nessuna lesione cutanea riferibile a sarcoma di Kaposi. Il sig. De Angelis convive con il partner, sig. Kwame Mensah, indicato come persona da contattare.

VIROLOGIA E SIEROLOGIA INFETTIVOLOGICA

Esame	Risultato	U.M.	Riferimento	Metodo / note
HIV-1 RNA plasmatico	Target non rilevato	copie/mL	LLOQ 20	RT-PCR real time
HBsAg	Non reattivo			CMIA
Anti-HBs	312	mUI/mL	> 10 protettivo	CMIA
Anti-HBc totali	Reattivo			Quadro di pregressa infezione da HBV con immunita'
Anti-HCV	Non reattivo			CMIA
Treponema pallidum Ab (TPHA)	Reattivo			Agglutinazione
RPR	1:8	titolo		Precedente 1:2 del 12.03.26: incremento di 2 diluizioni, sospetta reinfezione luetica (1)
QuantiFERON-TB	Negativo	UI/mL	< 0,35	IGRA

IMMUNOLOGIA CELLULARE - SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Linfociti totali	1.840	cell/µL	1.000 - 4.000	
Linfociti T CD3+	76,4	%	60 - 85	
Linfociti T CD4+	512	cell/µL	410 - 1.590	
Linfociti T CD4+ (percentuale)	27,8	%	31 - 60	L
Linfociti T CD8+	688	cell/µL	190 - 1.140	
Rapporto CD4/CD8	0,74		1,00 - 3,60	L
Nadir CD4 storico (2014)	186	cell/µL	-	

TEST GENOTIPICO DI RESISTENZA E FARMACOGENETICA

Viremia non rilevabile: test eseguito su **DNA provirale** (archivio) estratto da sangue intero, sequenziamento Sanger delle regioni pol (PR, RT, IN). Interpretazione con algoritmo HIVdb versione 9.6.

Regione	Mutazioni rilevate	Farmaci interessati	Interpretazione
Proteasi (PR)	nessuna mutazione maggiore	-	Sensibilita' conservata
Trascrittasi inversa (RT)	M184V	emtricitabina lamivudina	Resistenza di alto livello; attivita' residua per tenofovir
Integrasi (IN)	E157Q (polimorfismo)	bictegravir dolutegravir	Nessun impatto clinico atteso

Test farmacogenetico	Risultato	Implicazione
HLA-B*57:01 (PCR-SSP)	allele HLA-B*57:01 non rilevato	Nessuna controindicazione genetica all'uso di abacavir
UGT1A1*28 (genotipo)	omozigote (TA)7/(TA)7	Compatibile con sindrome di Gilbert; nessun aggiustamento della terapia in atto

ANDAMENTO STORICO (ULTIMI 4 CONTROLLI)

Data prelievo	N. accettazione	HIV-1 RNA (copie/mL)	CD4 (cell/µL)	CD4 %	Regime / note
12/03/2026	26RV004102	< 20 rilevato	478	26,1	BIC/FTC/TAF; RPR 1:2
18.09.25	25RV019877	Target non rilevato	455	25,3	BIC/FTC/TAF
3 marzo 2025	25RV003940	48	431	23,9	Blip viremico; aderenza ridotta riferita dal pz. durante uso di metanfetamine
14-10-2024	24RV021566	Target non rilevato	402	22,7	Switch da DTG/ABC/3TC a BIC/FTC/TAF (prescr. Dott. A. Marchionni)

CHIMICA CLINICA

Esame	Risultato	U.M.	Valori di riferimento	
Creatinina	1,08	mg/dL	0,70 - 1,20	
eGFR (CKD-EPI 2021)	84	mL/min/1,73 m²	> 90	L
Bilirubina totale	2,31	mg/dL	0,30 - 1,20	H
Bilirubina indiretta	1,94	mg/dL	< 0,80	H
ALT (GPT)	22	U/L	< 41	
Colesterolo LDL	128	mg/dL	< 116	H
Glucosio	91	mg/dL	70 - 99	
Fosfato	2,6	mg/dL	2,5 - 4,5	

Viremia persistentemente soppressa con ripresa immunologica parziale. La mutazione M184V archiviata non compromette il regime in atto. RPR in aumento in MSM con pratiche di chemsex: indicata rivalutazione infettivologica urgente e trattamento secondo protocollo. Referto da discutere con il sig. R. De Angelis esclusivamente in sede di visita.

Comunicazioni

Esito RPR comunicato il 5 ottobre 2026 alle 11:20 al Dott. Marchionni dalla Dott.ssa V. Orsini. Il pz. ha delegato il ritiro del referto al sig. K. Mensah (delega prot. 2026/DEL/3381).

Esecuzione analitica

Sequenziamento: TSLB Sara Cimini. Citofluorimetria: TSLB Marco Tozzi. Revisione bioinformatica: Dott. Paolo Nicastro.

Il Dirigente Biologo
Dott.ssa Valentina Orsini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Roma, 05/10/2026

POLICLINICO SAN CALLISTO
LAB. RETROVIROLOGIA
Dott.ssa Valentina Orsini
Ord. Biologi n. AA_062917

Referto di R. De Angelis - verifica online:
https://referti.aou-sancallisto.example.it/q/RV-26-0091174

(1) Titolo RPR confermato su secondo campione prelevato il 01/10/2026 (provetta RV26-13651-A).
(2) Si raccomanda la notifica al partner (sig. Mensah) secondo la procedura aziendale di partner notification.
(3) Valori di riferimento CD4/CD8 riferiti a soggetti adulti sieronegativi.